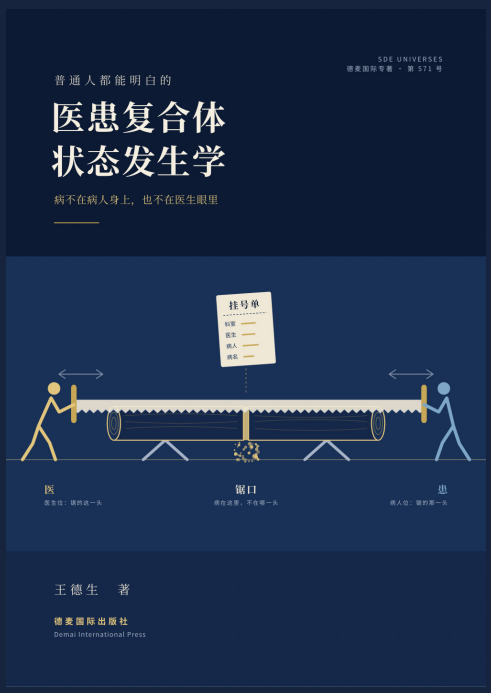
医患复合体状态发生学 · 学习包

四编 · 十六章 · 十六个学习单元



原书作者：王德生

ISBN 979-8-90690-590-1

第571卷 · US$20.00

先答、带问阅读、再答、讨论、本人修订、迁移与观察。

初答不覆盖；建议待核对；理解、赞同和现实应用分别记录。

本包是配套设计，不是著者原文或已验证训练量表。

在线学习：sdeuniverses.com/books/m/571/agent/learning.html

01 第1章：病人是挂号以后才有的位子

第 1 章 病人不是带着病来的

先想一件小事：你最近一次觉得「哪里不对」，是怎么变成「我得去看看」的？中间有谁说了什么？再带着问读第 1 章：第一，进诊室之前，一个人身上有的是什么——「病」，还是不适和苦？第二，为什么说「我是病人」是一个位子，不是一张身份证？第三，这个位子靠哪三样东西立起来？第四，七岁的豆豆没有自己走进诊室，是谁让他成了病人？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：进诊室之前只有不适和苦，「病人」是挂号之后和医生一起坐出来的位子；位子挂在场合上，不挂在人身上；它靠对面的人、一张单、一个词立起来，药店柜台是「坐了一半的位子」；周老师的血压数字没变，位子来了；有人难受很久不肯认自己是病人，怕的也许是那个位子而不是那个病。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第1单元

02 第2章：读数不同，是复合体不同

第 2 章 医生不是发现者

先想一件小事：你有没有拿着同一份结果，听到过两种不同的话？再带着问读第 2 章：第一，老看法说医生是发现者，它对在哪里？第二，换医生、换医院、换指南，读出来的病为什么会换——高血压那条线是怎么划出来的？第三，为什么本书说这不是误差，是复合体不同？第四，周岚的三个晚上说明了什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：本书先认下医生的专业与发现学的用处；读片者之间不一致、诊断线随指南移动，说明线是划出来的、病的名单是改过的；同一副身体读出不同的病，不是有人读错了，是拉的不是同一把锯；医生位也会换，周岚在诊室是医生，在父亲床前是家属，自己发烧时是病人。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第2单元

03 第3章：连观察者一起拆掉

第 3 章 观察者仍是发现学

先想一件小事：家里量的血压和诊室量的血压不一样，你先冒出来的念头是「哪个对」，还是「它们是在什么情形下量的」？再带着问读第 3 章：第一，本书为什么不写「量子力学证明了医学」，只借它什么？第二，玻尔的「现象」、巴拉德的「切」各走到了哪一步，又各留下了什么？第三，为什么说建构主义只是把发现者从幕后请到台前？第四，退相干的教训是什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：量子力学只作近邻，借的是它被「量的人」卡住的那个口子；玻尔把装置算进现象，巴拉德说关系不在关系项之前，可「切」仍要有人来切；建构主义是发现学的内部改良，仍有一个先在的发动者；退相干说明不需要意识，所以不写「意识影响病情」；本书的说法是观察者不先于观察，被观察的状态也不先于观察，两样都是同一场发生沉下来的东西。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第3单元

04 第4章：状态属于复合体

第 4 章 承载者换位：复合体

先想一件小事：你有没有读完药品说明书，就觉得不舒服了？再带着问读第 4 章：第一，「承载者」这个词是什么意思——一个状态算在谁的名下？第二，安慰剂为什么不是「假的」，反安慰剂又是怎样朝另一个方向走的？第三，医源性疾病与过度医疗，在老框架里是什么，在本书里变成了什么？第四，周岚为什么不对父亲说「爸，你想多了」？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：状态属于复合体，不属于其中任何一头；安慰剂、反安慰剂、医源性疾病、过度医疗，从要扣掉的干扰项变成正文；过度诊断与筛查的事实两面都要说，具体数字本书不引；「你想多了」会把整个晕推回一个人身上；说明书、一句话、一次等待，都是复合体在发生。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第4单元

05 第5章：诊断之前的一锅粥

第 5 章 诊断之前：没有形状的苦

先想一件小事：你最近一次说不清哪里难受，是什么时候？当时是谁在听，又是怎样听的？再带着问读第 5 章：第一，老看法把症状当成病的信号，它对在哪里？第二，为什么说一锅粥不是空的，里面缠着哪几样东西？第三，「没有方向」是什么意思？第四，三种常见的错认是哪三种？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：一锅粥（混沌态）是什么都在、还没分开；说不清哪里难受，不是你的错，是这锅粥还没找到形状；最难受的也许不是苦本身，而是没有方向；三种错认：把粥错认成病（急着装进病名的瓶子）、错认成空（「没事的，别想太多」）、错认成人的脾气；一锅粥里，医生位也在煮。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第5单元

06 第6章：诊断即开题

第 6 章 诊断即开题

先想一件小事：你或家人拿到一个病名的那天晚上，家里有什么变了？再带着问读第 6 章：第一，老看法为什么把诊断当终点？第二，诊断那一刻，哪三样东西一起显影？第三，「病名是第一次回写」是什么意思？第四，同一个名字落进三户人家，为什么长出不同的东西？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：发现学里诊断是终点，发生学里诊断是起点；挂号那一刻，病人位、医生位、病名一起显影；病名是第一次回写，写进病历，也写进日子；诊断不是对一副身体的判决，是复合体第一次翻开的作文题，题目出了，文章才开始，怎么写，是后面每一次见面的事。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第6单元

07 第7章：收回「科室就是测量基」

第 7 章 为什么「科室就是测量基」要收回

先想一件小事：你最近一次去看病，是怎么决定挂哪个科的？这个决定里，有多少是你自己的？再带着问读第 7 章：第一，「科室就是测量基」在什么条件下完全成立？第二，这个比喻的毛病，为什么落在一个「选」字上？第三，本书改成「科室与读数一起显出」，换掉的是什么？第四，老肖的胸口说明了什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：在体检流水线这类科室已经像磨好的尺子的场合，这个比喻成立；它的毛病是预设了一个站在测量之外、先挑好尺子的选择者；本书把它收窄为科室与读数是同一场拉锯里一起显出来的两面，科室、问法、仪器、病历上的格子都是推着读数长出来的土；这是全书一次公开的收窄，其他章用到这个比喻须指回这里。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第7单元

08 第8章：通路还是笼子

第 8 章 通路还是笼子：病名的两种回写

先想一件小事：你或身边的人，有没有拿过一个病名，后来发现它在日子里的分量，比医生那句话重得多？再带着问读第 8 章：第一，诊断好不好，老尺子问什么？第二，第二把尺子「通不通」看哪几件事？第三，周老师和老林拿到同一个诊断，为什么过成两种日子？第四，为什么说复诊与第二意见不是纠错，是重新起头？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：老尺子问准不准，这一把不能少；新尺子问开出来的是通路还是笼子：说得出吗、接得上吗、回得来吗；名字让苦可说、接上日子，是通路；名字一出口人先闭了嘴、成了称呼，是笼子；把「我是 X 病人」换成「我在管 X」；豆豆的「哮喘」例子是虚构的，本书不替任何真实的孩子下判断。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第8单元

09 第9章：悬着是治疗的主场

第 9 章 介生态：悬着的治疗

先想一件小事：你有没有等过一份检查报告？那几天，日子是怎么过的？再带着问读第 9 章：第一，老看法说病名一立、剩下的是执行，本书怎样换一个看法？第二，为什么说每一次复诊都是一次状态转换？第三，悬着为什么不是半成品？第四，「先观察」「不排除」「回去等通知」这些话，在医生位和病人位上，重量为什么不同？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：悬着（介生态）是形状已经冒头、却还没有站稳；病名立了，结局还没写，每一次复诊都是复合体换一个状态，不是检查方案有没有错；悬着是整个过程里最有创造也最危险的一段；悬着专用的话不是谎话也不是废话，把「通知大概什么时候来」补上，悬空就变成有边的悬着。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第9单元

10 第10章：定型靠一锅粥和悬着活着

第 10 章 秩序态依靠混沌态与介生态

先想一件小事：你认识「平时不生病，一病就很重」的人吗？再带着问读第 10 章：第一，老看法为什么把定型当终点？第二，蒸馒头和走路，各怎样说明定型靠一锅粥和悬着活着？第三，「不进入悬着」在日子里有哪三种样子？第四，反过来，一直悬着为什么也不是活法？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：定型不是终点，是靠一锅粥和悬着一次次托住的一站；走路每一步都悬着（王德生《悬着才成事》）；不去、不回、不改三种样子，做的是同一件事：不让一锅粥冒头、不让悬着发生；从不悬着的人，只是把一锅粥压到了更深的地方；医生那一头也有盖子；一直悬着同样不是活法。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第10单元

11 第11章：两种读数不对易

第 11 章 不对易：器质性与心因性

先想一件小事：你最近一次说「我查过了，没事」，是什么时候？那一次，有没有哪一半的自己没被问到？再带着问读第 11 章：第一，老看法「身体一半，心一半」底下藏着哪两样先在的东西？第二，先穿袜子还是先穿鞋，讲的是什么形状？第三，为什么越追一头，另一头越糊？第四，「查不出问题」的人卡在哪里？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：器质性与心因性不是身体里藏着的两样东西，是复合体的两种状态显影，一边亮，另一边就暗；问「各占多少」问错了地方；「查不出问题」是两种读数轮流亮、没有一次同时亮的复合体还没找到落脚的状态；老常追身体、不问日子，季阿姨只读日子、漏掉血里一项；这是比喻性的借用，附录四写明它最弱。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第11单元

12 第12章：解散是最好的痊愈

第 12 章 解散：最好的痊愈

先想一件小事：你最近一次看完病，有没有人跟你说过，什么时候可以不用再来？再带着问读第 12 章：第一，老看法说病好了就是病没了，本书多看见了什么？第二，复合体最好的秩序态为什么是「不再被需要」？第三，解散的三个动作是什么？第四，哪两头的复合体解散不了？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：复合体是被「需要」撑起来的，最好的一种秩序态是它不再被需要；解散不是失败，也不是告别；三个动作是病人位撤下、医生位撤下、病名退档；「我这个人身体不好」是病人位没有撤的痕迹；解散不了的两头是离不开医生、离不开检查的人，与离不开病人的医疗；好的复合体，是知道什么时候该散的复合体。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第12单元

13 第13章：医生端的症状

第 13 章 医生端的症状

先想一件小事：你见过一位很累的医生吗？那一刻，你觉得是他一个人的事吗？再带着问读第 13 章：第一，老看法为什么把倦怠、焦虑当成医生自己的事？第二，「锯另一头的热」这个比方说了什么？第三，倦怠、指标焦虑、防御性医疗，各对应复合体的哪一处？第四，为什么这一章不写成控诉？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：医生端的症状，是复合体的状态在医生位上先露出来的那一处；倦怠是回写进不来，指标焦虑是读数替了人，防御性医疗是多开的那张单；三样症状互相咬着，用老程那张单子串起来看；不写成控诉：追责仍在，复合体生病不是责任稀释；附录四写明这一章是解释，尚无统计支持。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第13单元

14 第14章：痛则不通的三处

第 14 章 痛则不通：复合体卡在哪一维

先想一件小事：你有没有在诊室里点了头，回家却跟家人说不清医生说了什么？再带着问读第 14 章：第一，「痛则不通」这句老话被本书借来问什么？第二，复合体要走通的那条路分哪三段？第三，说不出、读不懂、回写不进，各卡在哪里？第四，为什么说三处卡是连着的？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：复合体的痛是三处不通：苦没有转成可读的形状（说不出），知识没有接上这具身体的路（读不懂），方案没有在日子里发生（回写不进）；凯博文分出病人经历的疾痛与病历上的疾病（转述大意）；三处像一根管子上的三个弯，连在一起；挑最痛的一处，先通它。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第14单元

15 第15章：追到人，也追到锯口

第 15 章 复合体生病，责任在哪里

先想一件小事：你最近一次说或听到「这是他的错」，是在什么事上？再带着问读第 15 章：第一，老看法为什么只找那个有错的人？第二，「追到人，也追到锯口」是两件什么事？第三，「复合体生病」最常被读歪的三种读法是什么？第四，听到「不配合」，要先问哪三句？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：复合体生病不取消问责，追到那只手，也追到锯口卡住的那一维，两样都不放；三种读歪：没有人需要负责了、责任全在病人、医生也是受害者所以没有错；只追医生、只追病人、只追制度各有后果；追责本身是修复的一部分；「不配合」是读数不是原因，先问说得出吗、读得懂吗、回写得进吗；剂量单子的例子是虚构的。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第15单元

16 第16章：医生—病人—AI 三方复合体

第 16 章 医生—病人—AI：三方复合体

先想一件小事：你最近一次向机器问自己的身体，是在什么时候？那一问之前和之后，你的苦变成了什么样？再带着问读第 16 章：第一，老看法为什么把 AI 当一件工具？第二，说 AI 是一个位，不是在说哪三件事？第三，三方之后，说不出、读不懂、回写不进各变成什么样？第四，AI 出了错，名册上多了哪两行？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：挂号之前 AI 已先到场，诊室里已经是三方；说 AI 是一个位，不是说它有意识，不是说医生位、病人位被取代，也不是说它和另外两个位一样重；回写不进在三方里更要小心；出了错仍是追到手、追锯口：整理工序里没有一步保证病人的原话还在，签字容易变成点一下确认；这是人—AI 复合体的第一个可落地、可验证的行业样本。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与拉锯：第16单元